

SÍNDROME DE DOLOR REGIONAL COMPLEJO, DISTROFIA SIMPÁTICO REFLEJA O SUDECK

Jésica Rodríguez Álvarez, Sonia Ruth Navarro Prada, María Soledad Medina Martos.

INTRODUCCIÓN

Dolor difuso, de predominio distal, sin distribución metamérica y que no es proporcional al desencadenante que lo produjo. Es más frecuente en mujeres en torno a 40-50 años sin predilección por raza y siendo típica la afectación de un único miembro (especialmente el miembro superior) Tiene una incidencia de hasta el 35% según la población estudiada.

No tiene una etiología clara, pero si se sabe que un evento desencadenante puede producir un arco reflejo modulado por centros corticales ocasionando alteraciones vasculares.

Clasificación:

- Tipo I: No existe lesión nerviosa. Supone un 90%.
- Tipo II: Existe una lesión nerviosa definida.

Ambos presentan mismos signos y síntomas.

DIAGNÓSTICO

No existe una prueba específica que haga diagnóstico de SDRG.

Clínico

Dolor difuso, hipersensibilidad cutánea, ardor, edema, atrofia muscular, rigidez articular, sudor anormal y cambios en la textura de la piel del área afecta pudiendo verse brillante y delgada. Todos estos cambios se producen típicamente tras un evento desencadenante como por ejemplo inmovilización, fracturas o intervenciones.

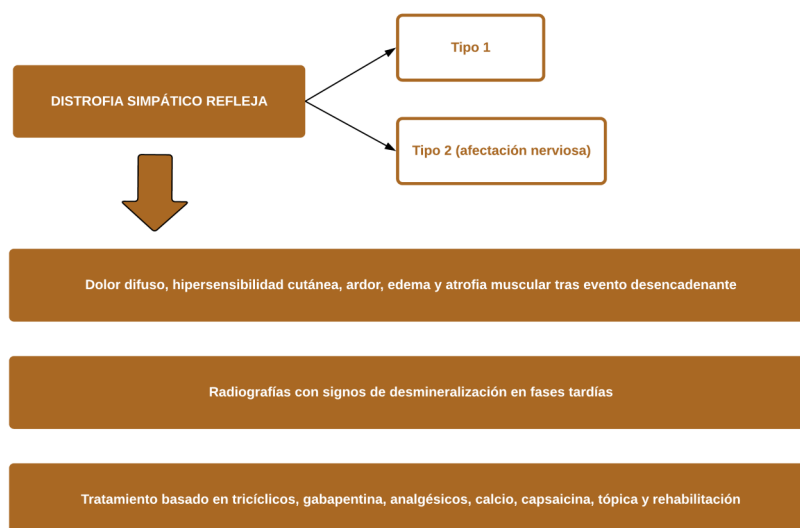
Se debe hacer un **diagnóstico diferencial** con otras patologías como pueden ser la trombosis venosa profunda, la tromboflebitis y celulitis, el linfedema, la insuficiencia vascular...

Pruebas Complementarias

- Radiografía: es más útil en fases tardías ya que se puede observar signos de desmineralizaciones.
- TAC: asimetría de flujo en las fases 1, 2 y/o 3
- Gammagrafía ósea: nos ayuda para realizar un diagnóstico precoz cuando todavía la radiografía es normal. Se observa un aumento de captación en la fase ósea.
- Las pruebas de laboratorio no nos suelen aportar información.

TRATAMIENTO

- Consenso de expertos recomienda la utilización de: Tricíclico (ejm. Amitriptilina) + anticonvulsivante (ej. Gabapentina) + AINE/ opioide.
- Otros fármacos utilizados: calcio, capsaicina tópica...
- Rehabilitación: derivar de forma preferente.



BIBLIOGRAFÍA

- Physiotherapy for pain and disability in adults with complex regional pain syndrome types I and II (Review). Smart KM, Wand BM, O'Connell NE. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 24;2.
- Complex regional pain syndrome in adults: UK guidelines for diagnosis, referral and management in primary and secondary care. London: RCP, 2018.